Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Причины 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

2.5 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Осмотр и консультации 6

3.3 Посев 6

3.4 Инструментальные исследования 7

4. Лечение 7

4.1 Базовая терапия 7

4.2 Системные антибиотики 7

4.3 Местные антибиотики 8

4.4 Другие лекарства 9

4.5 Хирургическое лечение 9

4.6 Другое лечение 10

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 10
5.1 После операции 10
5.2 Профилактика 10
5.3 Госпитализация 11
5.4 Прогноз 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности в самом тексте КР 11

1. Главное

- Хронический синусит у взрослого диагностируют, если два симптома или больше держатся 12 недель и дольше, причём один из них — заложенность носа или выделения из носа; диагноз подкрепляют эндоскопические признаки или изменения на КТ.
- Основа консервативного лечения — промывание носа солевым раствором всем пациентам и интраназальные глюкокортикостероиды с 12 лет; чтобы оценить эффект гормонов, их применяют не меньше 3 месяцев.
- Системные антибиотики назначают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике — амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию.
- Случайно найденную бессимптомную кисту пазухи большинство экспертов не оперируют: многие кисты медленно уменьшаются сами или не меняются.
- Мукоцеле медленно растёт, растягивает и иногда разрушает стенку пазухи, поэтому его всегда лечат хирургически.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух, которое держится больше 12 недель и сопровождается двумя симптомами или больше. Один из них — заложенность носа или выделения из носа (наружу или в носоглотку); к нему могут добавляться боль или давление в области лица и снижение или потеря обоняния.

Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты пазух образуются, когда закупориваются выводные протоки желёз слизистой; изнутри и снаружи они выстланы мерцательным цилиндрическим эпителием. Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты лежат в толще слизистой, не имеют внутренней эпителиальной выстилки и возникают из-за хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле — доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование пазухи. Оно возникает, когда естественное соустье стойко перестаёт дренировать пазуху, и часто растягивает, реже разрушает её стенки.

2.2 Причины

С развитием ХРС связывают аллергический ринит, первичную цилиарную дискинезию, муковисцидоз, бронхиальную астму, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), иммунодефицит и аутоиммунные системные болезни.

Важный фактор риска — анатомические особенности в области остиомеатального комплекса: искривление перегородки носа, буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина, гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки, аномалии крючковидного отростка, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи. Они нарушают вентиляцию носа и отток секрета из носа и пазух. У детей, гораздо реже у взрослых, ХРС бывает связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольников, главная причина ХРС — муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По отечественным данным, связи между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не найдено.

Предрасполагать к ХРС может и аллергический отёк слизистой в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с болезнями зубов и стоматологическим лечением. Хронический верхнечелюстной синусит может осложнять периодонтит или пародонтит; частая причина — эндодонтическое лечение, когда в пазуху через каналы попадают инфицированный детрит или пломбировочный материал. Воспаление в пазухе могут вызвать и дентальная имплантация с предшествующим наращиванием кости. При одонтогенном синусите среди возбудителей преобладают анаэробы.

ГЭРБ тоже может способствовать ХРС: рефлюктат, попадая на слизистую носа и носоглотки, вызывает воспаление и нарушает мукоцилиарный клиренс, а это может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важный фактор риска — курение: табак токсичен для слизистой носа, сушит её и меняет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалением в носу и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты чаще всего вызывает хроническое, прежде всего аллергическое, воспаление слизистой; риск повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста растёт из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба, зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё, фолликулярная развивается очень медленно из зубного фолликула.

Мукоцеле в подавляющем большинстве случаев — следствие операций на пазухах; другие причины — травма, хроническое воспаление пазух, опухоли и лучевая терапия. Больше чем в трети случаев причину найти не удаётся; описаны и врождённые мукоцеле. У детей мукоцеле чаще всего возникает из-за вторичного хронического синусита при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации, с указанием стороны, синусит бывает верхнечелюстным, этмоидальным, фронтальным и сфеноидальным. Если воспалены пазухи только одной стороны, говорят о гемисинусите, если несколько пазух — о полисинусите.

В практике принято делить хронический синусит на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По возбудителю синусит бывает бактериальным, грибковым и бактериально-грибковым.

По тяжести течения, которую оценивают по суммарной выраженности симптомов на визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10, выделяют лёгкую форму (0–3 балла), среднетяжёлую (4–7) и тяжёлую (8–10).

> Классификация по тяжести ссылается на приложение Г1, но там описана ВАШ только для интенсивности боли и с другой градацией: до 2 см — слабая боль, 2–4 — умеренная, 4–6 — сильная, 6–8 — сильнейшая, до 10 — невыносимая. Как считать суммарную выраженность симптомов, в КР не сказано.

Классификация EPOS 2020 года построена на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит бывает односторонним (локализованным) — с воспалением 2-го типа или не 2-го типа, сюда же относят аллергический грибковый и изолированный синусит одной пазухи — и двусторонним (диффузным) — с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний бывает механическим, воспалительным и иммунным; его фенотипы — первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

Кисты в России обычно делят по классификации М. И. Кадымовой на ретенционные, лимфоэктатические, одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи и кисты, связанные с пороками развития.

Больше 90% кист находятся в верхнечелюстной пазухе, около 5% — в клиновидной, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта — крайне редко. Больше чем в 80% случаев киста односторонняя; несколько кист бывает лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; некоторые авторы считают самой частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны и крайне редкие места — нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиника ХРС неспецифична: заложенность носа, выделения спереди и по задней стенке глотки, головная или лицевая боль, снижение или отсутствие обоняния, ощущение неприятного запаха в носу. Главные симптомы, сильнее всего влияющие на самочувствие, — заложенность и выделения. У детей ключевым симптомом бывает и кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки. От острого синусита хронический отличается тем, что симптомы держатся больше 12 недель, не проходя полностью.

Кисты пазух часто ничем себя не проявляют и находятся случайно на снимках головы. Большая киста чаще всего вызывает головную или лицевую боль, редко — внезапное истечение из носа янтарной жидкости при самопроизвольном разрыве, онемение верхней губы или зубную боль. Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, скорее всего, вызваны сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от его локализации и размера. Основные симптомы — головная боль, давление в области лица, заложенность носа, выделения и боль вокруг глаза. Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, но гораздо реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Взрослые жалуются на стойкую, одностороннюю или попеременную заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, необходимость сморкаться или стекание слизи по задней стенке глотки — сильнее после пробуждения или постоянно в течение дня, на неприятный запах в носу или носоглотке, снижение обоняния вплоть до аносмии. При хроническом сфеноидите бывает периодическая боль в темени и затылке.

Для хронического фронтита характерна сильная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Бывает ощущение давления позади спинки носа и глазных яблок, сильнее при обострении.

У маленьких детей жалобы узнают от родителей или опекунов: частые затяжные «насморки», заложенность носа, слизистые выделения, кашель, в основном ночью или лёжа на спине.

Если на снимках нашли кистоподобное образование, прежде всего выясняют, есть ли головная или лицевая боль, постоянна ли она и что её вызывает или усиливает. Расспрашивают о прошлых операциях на носу и пазухах и стоматологическом лечении.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У взрослого хронический синусит диагностируют, если 12 недель и дольше есть два симптома или больше, причём один из них — заложенность носа, затруднённое носовое дыхание или выделения из носа (спереди или по задней стенке глотки); к ним могут присоединяться боль или распирание в проекции пазух и снижение или потеря обоняния. Диагноз подкрепляют эндоскопические признаки — полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой, в основном в среднем носовом ходе, — и изменения слизистой остиомеатального комплекса или пазух на КТ.

У ребёнка нужны два симптома или больше в течение 12 недель и дольше из четырёх: затруднённое носовое дыхание, боль или распирание в проекции пазух, выделения из носа или стекание по задней стенке глотки, кашель. Эндоскопические признаки и изменения на КТ те же, что у взрослых.

Кисту пазухи диагностируют по КТ или МРТ: округлое однородное мягкотканное образование на широком основании с чёткими границами, без разрушения кости и выраженной деформации стенок. Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Одонтогенную кисту верхнечелюстной пазухи диагностируют по КТ — однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи, с чёткими границами, оболочкой костной плотности и связью с корнями верхних зубов — вместе с заключением стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о болезни соседних зубов.

Мукоцеле диагностируют по КТ: образование в пазухе с округлым ровным контуром и однородным содержимым без кальцинатов и включений; соседние кости могут истончаться, а образование — выпячиваться в соседние области.

3.2 Осмотр и консультации

Всех пациентов с хроническим синуситом и с подозрением на кисту или мукоцеле осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, собирает жалобы и анамнез, планирует лечение.

Если аллергологический анамнез отягощён, пациента с хроническим синуситом, а взрослого — и с подозрением на кисту или мукоцеле, консультирует аллерголог.

При симптомах рефлюкса пациента консультирует гастроэнтеролог.

При признаках муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии пациента консультирует генетик.

При подозрении на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи пациента консультирует стоматолог-хирург или челюстно-лицевой хирург, чтобы подтвердить или исключить зубную причину.

3.3 Посев

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при обострении гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, чтобы подобрать или скорректировать антибиотик.

Лучший материал — аспират прямо из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или во время операции.

3.4 Инструментальные исследования

Всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом проводят эндоскопию полости носа и носоглотки, чтобы осмотреть синоназальные структуры и подтвердить диагноз.

Спиральную КТ пазух делают при признаках осложнений во время обострения, перед операцией и когда нужна дифференциальная диагностика.

КТ — самый информативный метод и у взрослых, и у детей. Она показывает изолированное воспаление, блок соустья, инородное тело, диффузный грибковый процесс или мицетому, опухоль, аномалии пазух, позволяет заподозрить одонтогенную причину. Типичные признаки ХРС — утолщение слизистой и снижение пневматизации в области соустий.
Чтобы спланировать объём операции, КТ делают не раньше чем за 6 месяцев до неё.

Спиральную КТ пазух делают всем пациентам с подозрением на кисту, найденную другим методом и дающую постоянные или периодические симптомы, и всем с подозрением на мукоцеле.

Если мукоцеле трудно отличить от других образований, КТ делают с внутривенным болюсным контрастированием: контраст накапливают оболочка мукоцеле, но не его содержимое.

---

4. Лечение

Причин ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основа консервативного лечения — лекарства; по показаниям их можно назначать и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательств, что кисты и мукоцеле пазух поддаются консервативному лечению, нет; симптомы могут уменьшиться, только если лекарства помогают при сопутствующем ХРС или аллергическом рините.

4.1 Базовая терапия

Всем пациентам с ХРС назначают промывание носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором: оно очищает полость носа и уменьшает нагрузку антигенами на слизистую.

Промывание важно и как часть лечения после операции.

Пациентам старше 12 лет назначают интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС), чтобы уменьшить симптомы.

Единой схемы доз, кратности и длительности нет, допустимы и низкие, и высокие дозы. Чтобы оценить эффект, лечение продолжают не меньше 3 месяцев.
Носовые кровотечения из-за сухости слизистой чаще бывают при высоких дозах. Официально зарегистрированное показание при хроническом риносинусите есть только у назального спрея мометазона: взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, то есть 400 мкг в сутки.

4.2 Системные антибиотики

Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с болезнями, повышающими риск бактериальной инфекции.

Препарат	Когда и в какой дозе
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой меньше 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензию 400/57 мг в 5 мл дают по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. С массой больше 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг — 8 мг/кг в сутки 1 раз в день; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в день.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	Если не помог амоксициллин с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в день, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым амбулаторным пациентам при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курсом 10–14 дней. Знак # означает применение вне инструкции.

Ребёнка с обострением, которому нужны системные антибиотики, но нельзя назначить пенициллины, лучше лечить в стационаре; препарат выбирают по тяжести, локализации и распространённости воспаления и чувствительности выделенного микроба.

Если стартовый антибиотик амбулаторно не помог, стоит решить вопрос о направлении пациента в ЛОР-отделение стационара по неотложному каналу. В стационаре при среднетяжёлом течении лучше давать препараты внутрь, а если это невозможно — парентерально; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.

Если не помогли цефалоспорины III поколения или выделены устойчивые к ним штаммы, назначают препарат резерва — цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие — с учётом чувствительности возбудителя.

Эффект антибиотика должен появиться на третьи сутки; если он есть, препарат продолжают 10–14 дней.

4.3 Местные антибиотики

При лёгком обострении у пациента, которому раньше делали синусотомию, при появлении гнойных выделений назначают местные антибиотики.

Эффект оценивают через 3–4 дня; если его нет, решают вопрос о системных антибиотиках.

В России при ХРС зарегистрированы назальный спрей фрамицетина — для детей с первых лет жизни — и комбинированный спрей с дексаметазоном, неомицином, полимиксином B и фенилэфрином — с 2,5 лет. Разовую и суточную дозы соблюдают строго по инструкции. Фрамицетин при обострении применяют не дольше 7 дней, комбинированный препарат — не дольше 10 дней.

Растворы антибиотиков для внутримышечного и внутривенного введения в нос и пазухи вводить нельзя: они для этого не предназначены и повреждают мерцательный эпителий. В пазуху можно вводить тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Другие лекарства

При обострении, если нет противопоказаний, назначают растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием, чтобы симптомы прошли быстрее.

Эффективны комбинированные препараты с экстрактами корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.

При обострении назначают сосудосуживающие капли или спреи в нос, чтобы облегчить отток секрета из пазух.

Нафазолин очень токсичен, в ЛОР-практике его применять нельзя. Предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%. Применяют их строго по назначению и под контролем врача, не дольше 5–7 дней, иначе возникает медикаментозный ринит.

Муколитики назначают, чтобы разжидить отделяемое и облегчить его отток.

Карбоцистеин дают коротким курсом, до 2–3 недель, при обострении с густым секретом в носу; возможны и курсы около 3 месяцев вместе с противовоспалительными средствами. Одновременно с другими отхаркивающими и муколитиками, в том числе местными, его не назначают, иначе усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

При температуре, головной или лицевой боли во время обострения назначают нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки.

4.5 Хирургическое лечение

При тяжёлом обострении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, оперируют в неотложном или экстренном порядке. При среднетяжёлом обострении, если консервативное лечение не помогает, можно неотложно провести малоинвазивные манипуляции. Остальных пациентов оперируют планово по показаниям; если показаний нет или есть противопоказания, лечат консервативно и наблюдают у оториноларинголога.

Под функциональной риносинус-хирургией КР понимает фронтотомию, этмоидотомию, сфеноидотомию, гайморотомию и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых, если позволяет оснащение, предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановой операции она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют планово, обычно теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи иногда используют микрогайморотомию и фронтотомию через переднюю стенку.

При тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, а при среднетяжёлом — если консервативное лечение не помогает, пазуху пунктируют, чтобы её дренировать.

Через пункцию пазуху промывают антисептиком, удаляют секрет и вводят антибиотик.

Пунктировать можно только при наличии снимков, которые исключают гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и показывают скопление в ней секрета.

При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию делают только в стационаре.

Для дренирования можно поставить синус-катетер или зондировать пазухи через естественные соустья.

Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию, чтобы восстановить аэрацию пазух, убрать симптомы и предотвратить осложнения.

> Внутри КР есть расхождение: в рекомендации об операции у взрослых показанием служит неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, а в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Ребёнку с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени, если консервативное лечение 3–6 месяцев не помогло, первым этапом удаляют аденоиды.

Операцию делают планово, если нет противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в ЛОР-отделении или стационаре кратковременного пребывания и, если есть оснащение, с эндоскопом.

Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС, если лечение 3–6 месяцев не помогло, а гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены больше 6 месяцев назад, выполняют функциональную эндоскопическую риносинус-хирургию.

Оперируют планово. Операция не мешает росту пазух и лицевого скелета, но у детей выше риск рубцов и повторного сужения, а маленькие структуры требуют современного оборудования.

Детям с изолированным поражением пазухи выполняют эндоскопическую операцию, чтобы её дренировать.

Её делают независимо от состояния аденоидов, если на КТ видно отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации и есть типичные жалобы. У детей нужна онконастороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, которые не растут.

Кисту пазухи с постоянными или периодическими симптомами удаляют эндоскопически: опорожняют её и полностью или частично удаляют оболочку.

Случайно найденную бессимптомную кисту большинство экспертов оперировать не советуют: кисты, кроме одонтогенных, часто медленно уменьшаются сами или не меняются.

Всем пациентам с мукоцеле выполняют эндоскопическую операцию, чтобы его дренировать.

При лобной локализации лучшим методом считают эндоскопическую марсупиализацию с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле, распространяющемся в полость черепа, используют наружный доступ.

4.6 Другое лечение

Пациенты со вторичным ХРС, у которых изменения в носу и пазухах — проявление другой болезни, наблюдаются и лечатся у профильного специалиста. Одонтогенные кисты верхнечелюстной пазухи лечат вместе со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 После операции

После операции всех пациентов амбулаторно наблюдает оториноларинголог, чтобы оценить состояние полости носа и не пропустить поздние осложнения.

Первый осмотр — через 7–14 дней после выписки, затем ещё несколько раз в течение года, чтобы следить за течением болезни и вовремя менять лечение. Осмотры нужны, чтобы контролировать полость носа (при плохом уходе образуются корки и синехии), выявлять и предотвращать осложнения и при необходимости выполнять манипуляции.

Месяц после операции пациент соблюдает щадящий режим и избегает всего, что повышает давление и может вызвать кровотечение: интенсивных нагрузок, перегрева и переохлаждения. Чтобы не заразиться острой респираторной инфекцией, лучше не бывать в людных местах и больше оставаться дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика защищает от вредных факторов среды, вторичная — выявляет болезнь как можно раньше. Хроническому синуситу помогают предотвратить своевременное лечение зубов и гастроэзофагеального рефлюкса, отказ от курения и техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Мукоцеле предупреждает соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на носу и пазухах, лимфоэктатические кисты — своевременное лечение хронического воспаления в носу, радикулярные кисты — своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту объясняют, что хронический синусит трудно вылечить, но его симптомы можно уменьшить; обычно нужен пожизненный контроль, а тактику определяет оториноларинголог, иногда вместе с другими специалистами.

Важно изменить образ жизни: бросить курить или хотя бы курить меньше, а при аллергии соблюдать гипоаллергенный быт. Важны и приверженность лечению, соблюдение доз, правильная техника введения лекарств и промывания.

5.3 Госпитализация

Пациентов с хроническим синуситом, кистами и мукоцеле лечит прежде всего оториноларинголог, при необходимости вместе с аллергологом-иммунологом, гастроэнтерологом, ревматологом, стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом. Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

В ЛОР-отделение экстренно госпитализируют при внутричерепных или внутриглазничных осложнениях, при тяжёлом обострении, а при среднетяжёлом — если амбулаторное лечение 5–7 дней не помогло или состояние прогрессивно ухудшается в любые сроки.

Планово для операции госпитализируют при подтверждённом хроническом синусите, не отвечающем на адекватную консервативную терапию 6 месяцев; при возврате симптомов после операции; у детей, у которых жалобы и признаки синусита сохраняются после удаления аденоидов; при изолированном воспалении с субтотальным или тотальным снижением пневматизации на КТ дольше 2 месяцев; при подозрении на новообразование пазухи неясной природы; при «синдроме молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи на КТ; при кисте с постоянными или периодическими симптомами и при мукоцеле.

Выписывают, когда операция выполнена в нужном объёме, общее состояние удовлетворительное и нет местного или системного острого инфекционного воспаления.

5.4 Прогноз

Успех лечения зависит от анатомии носа и пазух у конкретного пациента, хронических системных болезней, активного и пассивного курения, профессиональных вредностей, климата и экологии, а также от того, насколько пациент соблюдает лечение.

Одонтогенные кисты сами не проходят, и их лечат несколько специалистов вместе.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки операции у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии — после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации

(раздел 6) — после 6 месяцев неэффективной терапии.

- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, где описана ВАШ только для боли и с другой градацией.
- В определении симптомы должны держаться «более 12 недель», а в критериях диагноза — «12 недель и более» (≥12 недель).
- Удаление аденоидов в рекомендации названо «аденоидэктомией», а в комментарии к ней — «аденотомией».
- В комментарии об антибиотиках у детей повторяется оборот: «в случае невозможности применения при невозможности применения».
- В оглавлении разделы «Хирургическое лечение» и «Иное лечение» пронумерованы как «3.» вместо 3.2 и 3.3.